要介護認定調査票・ペルソナ症例 06

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	伊藤 誠（いとう まこと）	**年齢 / 性別**	80歳 / 男性
要介護度	要介護2	**調査実施者**	地域包括支援センター職員（保健師）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】訪問看護週2回（インスリン・血糖管理）、訪問入浴介護週1回、配食サービス週3回

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】独居（持ち家の一軒家）。長女が車で20分に居住し週末に訪問。
【居住環境】一軒家（階段・段差あり）。
【主な介護者】なし（フォーマルサービスおよび長女が支援）。
【傷病・既往歴】糖尿病性末梢神経障害、両下肢動脈閉塞症、加齢黄斑変性症（視力低下）。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	糖尿病性末梢神経障害、両下肢動脈閉塞症（ASO）、加齢黄斑変性症
傷病の経過・治療内容	糖尿病性合併症による下肢しびれと脱力感、および両眼の視力低下が進行。単独での屋外移動が困難となり、独居生活における安全上の懸念が増大している。
医学的管理の必要性	インスリン自己注射の手技確認および血糖自己測定（SMBG）の指導管理、降圧薬等の内服管理、定期的な眼科・内科受診。
身体障害に関する意見	下肢の感覚障害・しびれおよび視力障害により、バランス保持が不安定。屋内は杖や壁伝いで移動可能だが屋外歩行は困難。
精神・認知機能の意見	認知機能はクリアで判断力に問題はないが、極めて頑固で他人の介入を強く拒絶する傾向がある。
特別医療・ケアの必要性	視力低下および末梢神経障害があるため、インスリン注射の単位設定や内服管理、および調理時の火気使用における医療安全上の見守りが必須。
介護に関する医学的意見	独居を希望しているが、医療管理（インスリン）や安全確保の観点から支援が不可欠。訪問看護による週数回の服薬・注射管理、配食サービス、および見守り体制を構築する。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし（末梢神経障害によるしびれ・脱力感） (2)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：なし (1)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：自立 (1)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：自立（視力低下のためバランス注意） (2)
9. 歩行：屋内は杖または壁伝いで自立、屋外は不安定 (2)
10. 立ち上がり：自立 (1)
11. 片足立ち：不可能 (4)
12. 洗顔：自立 (1)
13. 爪切り：一部介助（視力低下のため訪問看護師が補助） (2)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：自立 (1)
2. 移動（屋内）：自立（慣れた自宅） (1)
3. 移動（屋外）：一部介助（視力障害と下肢しびれのため単独外出危険） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立 (1)
6. 排泄（排便コントロール）：自立 (1)
7. 衣服着脱（上衣）：自立 (1)
8. 衣服着脱（ズボン等）：自立 (1)
9. 入浴：一部介助（浴室内の転倒防止補助） (2)
10. 口腔清潔：自立 (1)
11. 洗髪：一部介助（視力低下のため洗い残し確認） (2)
12. 買い物：できない (4)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶：しっかりしている (1)
4. 日付の理解：わかる (1)
5. 場所の理解：わかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：わかる (1)
9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：あり（「俺は一人でできる」と頑なに拒否） (3)
7. 羞恥心の喪失：なし (1)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：一部介助（訪問看護師が週数回インスリン・内服管理） (2)
2. 金銭管理：一部介助（長女がサポート） (2)
3. 簡単な調理：一部介助（配食サービス利用、温めのみ） (2)
4. 電話の利用：自立（音声読み上げ等使用） (1)
5. 社会的交流：一部介助（孤立傾向だが本人希望は薄い） (2)
6. 日常の意思決定：自立 (1)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

80歳独居男性。糖尿病性末梢神経障害による下肢しびれと重度の視力低下がある。認知機能はクリアだが非常に頑固で他人の介入を嫌う。インスリン自己注射や調理中の火災リスクがあり見守りが不可欠。独居高齢者向け安否確認・見守りチャットシステム、音声操作型スマートホームの検証に最適。